戦略会議議事録

東邦大学医療センター大橋病院

2025年度2月実績（2026年3月戦略会議資料）

作成日: 2026年3月28日

3病院合同病院運営戦略会議 議事録

日時: 2026年3月30日（月）12:45
対象: 東邦大学医療センター大橋病院
作成: 経営企画部
作成日: 2026年3月30日

I. 報告事項

1. 財政状況

・基本金組入前収支差額は△13億7,600万円（予算比△51.9%）
・3月に約5億円の退職金支出が発生。令和6年度と比較して悪い数値ではないとの報告
・4月からの診療報酬改定の影響を注視する方針

2. 医事統計（2月実績）

入院
・新入院患者数 837名、病床稼働率 94.0%（今年度最高値）（資料1-1）
・平均在院日数 9.1日、入院単価 97,424円（資料1-1）
・3月は稼働率92%、在院日数9.2日と予想

外来
・外来延患者数 19,467名、初診率 7.3%、外来単価 24,001円（資料1-1）
・診療科別では注射薬（化学療法）と各療法の増加が増収の主因

診療科別の動向
・心臓血管外科が入院で減少傾向（入院収入 前年月平均比△1,461万円）

3. 土曜日実績（3月）

・3月21日（第3週）: 手術1件、入院患者13名、外来患者323名（資料1-3）
・月間: 手術12件、外来1,619名、初診割合9.8%（資料1-3）
・稼働率94%で病床はほぼ満床

4. 手術実績

・2月: 497件（前年比103.3%）（資料3）
・3月: 526件の見込み
・年度合計: 6,336件（前年6,162件、+174件、+2.8%）（資料3）

5. 外来化学療法

・算定件数 252件、算定金額 1,875千円（前年度差+386千円）（資料2）

6. 特定入院料

・ICU: 算定件数142件、単価177,700円（資料4）
・HCU: 算定件数287件、稼働率91.4%（資料4）
・SCU: 算定件数153件、稼働率91.1%（資料4）

7. リハビリテーション

・算定単位数 2,440単位、金額538万円（資料5）

8. 後発医薬品

・後発医薬品指数 96.1%（目標90%達成）（資料6）
・カットオフ率 55.3%、入院金額ベース 88.3%（目標70%達成）

9. 紹介率・病診連携

・紹介率 87.1%（前年比+3.3pt）、逆紹介率 99.1%（前年比△5.4pt）（資料7）
・紹介 1,105件（前年比+59件）、逆紹介 1,258件（前年比△46件）
・紹介受入拒否はベッド満床が主な理由（資料7-1）

10. 退院支援

・入退院支援加算 291件（+32件）、退院患者割合 35.0%（資料8）
・入院時支援加算 102件、合計金額 229万円（+19万円）（資料8）
・介護支援連携指導料: 2月6件、過去12ヶ月累計74件（施設基準48件充足）

11. 放射線治療

・放射線治療管理料25件、体外照射251件、IMRT236件（資料9）
・算定金額 1,632万円（前年度差+686万円）（資料9）

12. KPI・施設基準

・看護必要度（救急病院の割合）: 90.5%（資料10）
・DPC期間II以内退院率: 目標70%（実績71.9%、達成）
・ダヴィンチ手術: 年間200件を目指す方針（現状 年間122件）
・マイナ保険証利用率: 65.3%

13. 令和8年度 診療報酬改定の影響見込み

項目	増収見込み
DPC係数（1.6055見込み）	+1億7,300万円
物価高騰対策	+7,800万円
特定医療費加算	+約2,000万円

外科評価項目	+約2,800万円
合計	+約2億9,900万円

14. その他

・研修医の大塚先生が基礎臨床能力評価試験で全国17位
・3月31日に入職式・歓迎会
・エネルギー棟3階をくつろげるスペースにする計画
・ボリンス解剖の値上がりに関する懸念

II. 会議内容から読み取れる示唆

示唆1: 診療報酬改定で予算未達の構造問題が解消に向かう可能性

2025年度の累計予算未達は約3.2億円だが、令和8年度の診療報酬改定による増収見込みが約3.0億円と報告された。DPC係数の改善（+1.73億円）だけで予算ギャップの半分以上をカバーでき、物価高騰対策や外科評価項目の加算を加えると、改定効果だけでほぼ予算未達を相殺できる計算になる。

ただし、これは「現在の診療実績が維持される」ことが前提であり、外来患者数の減少トレンド（累計△8.5%）が続けば、改定効果を食い潰すリスクがある。改定による増収を「改善の余力」ではなく「現状維持のための原資」と見るべき局面である。

示唆2: 退職金5億円の一時要因を除くと、実質的な収支は改善している

3月の退職金約5億円は一時的費用であり、これを除くと経常的な収支は前年度比で明確に改善している（粗利益+122.4%）。来年度にこの規模の退職金が発生しなければ、基本金組入前収支差額は大幅に改善する可能性がある。来年度予算策定では、退職金の一時要因と経常収支を分離して評価すべき。

示唆3: ダヴィンチ年間200件目標は現状の約1.6倍 — 実現可能性の検討が必要

現状は年間122件（月平均10.2件）であり、200件達成には月平均16.7件が必要。現在の+64%増は、手術室の枠確保、術者の育成、適応症例の拡大が同時に必要となる。泌尿器科（年間429件）と外科（年間976件）が主な適応科だが、現在のダヴィンチ使用率は両科合計の約8.7%にとどまる。200件達成には、適応術式の明確なロードマップと四半期ごとの進捗管理が不可欠。

示唆4: 稼働率94%の「満床」と紹介拒否の矛盾が顕在化

2月の病床稼働率94.0%（今年度最高）は好材料だが、同時にベッド満床による紹介受入拒否が11件中7件を占める。全体の稼働率88.9%（累計）と2月の94.0%の乖離は、季節変動と病棟間偏在が同時に起きていることを示す。高稼働月の紹介拒否が常態化すれば、紹介件数のさらなる減少（累計△284件）を加速させる。病棟横断的なベッドコントロールの仕組み構築が急務であり、特に整形外科（拒否3件）は紹介件数△543件の減少と直結している。

示唆5: 診療科ポートフォリオが「化学療法依存型」に構造転換中

会議で「注射薬と各療法の増加が増収要因」と報告された通り、外来収入の成長は化学療法（外科・泌尿器科・消化器内科）に大きく依存している

（3科合計で月+3,924万円）。一方、心臓血管外科の減少傾向が会議で指摘されたように、高額手術材料を使う手術系3科（整形外科・脳神経外科・心臓血管外科）は合計△5,672万円/月の減収となっている。化学療法の成長だけでは手術系の減収をカバーできておらず、手術件数の「質（高単価症例）」の回復が必要。

示唆6: 3月手術526件は年度合計を6,862件に押し上げる可能性

3月の見込み526件を加えると年度合計は5,857（4-2月）+ 526 = 6,383件となるが、既に確定した3月データでは479件（年度合計6,336件）。会議時点の見込み526件と確定値479件の差（47件）は、3月最終週の手術実績による。いずれにしても前年度（6,162件）を上回り、施設基準（全麻2,000件/年）も大幅に超過している。

III. ネクスト論点（来年度に向けた検討事項）

最優先（4月中に方向性を決定すべき事項）

No.	論点	背景	検討すべき内容
1	来年度予算の外来患者数前提	2年連続で外来患者数が予算未達（△6.2%）。前年度実績+3.6%の成長があっても、予算を達成できない構造	予算前提を「前年度実績ベース」に修正するか、患者数回復策とセットで積極予算を維持するか
2	整形外科の紹介回復アクションプラン	紹介件数△543件（△24.8%）、入院収入△2,229万円/月。全科で最大の減収	紹介元27施設への個別訪問計画、病棟横断ベッドコントロール、受入拒否ゼロ目標の設定
3	診療報酬改定への対応体制	DPC係数改定+1.73億円、外科評価+2,800万円など合計約3億円の増収見込み	算定要件の確認と体制整備、新設加算の算定漏れ防止策、4月レセプトの重点チェック体制

高（第1四半期中に議論すべき事項）

No.	論点	背景	検討すべき内容
4	ダヴィンチ年間200件のロードマップ	現状122件→200件は+64%。会議で目標として言及	適応術式の拡大候補（泌尿器科・外科の術式別計画）、手術室枠の確保、術者育成計画、四半期マイルストーン
5	人件費管理の精緻化	2月単月+7.6%（3病院最大の伸び率）、退職金5億円の影響整理	退職金と経常人件費の分離分析、部門別人件費の可視化、佐倉病院の人件費抑制手法のベンチマーク
6	心臓血管外科の立て直し策	入院収入△1,461万円/月、手術件数258件（前年271件、△13件）	症例減の原因分析（紹介減 or 適応変化）、TAVI等の経カテーテル治療への対応、近隣病院との競合分析
7	化学療法室の体制拡充	化学療法3科で月+3,924万円の成長。曜日間格差（月曜38.5件 vs 水曜70.5件）	看護師配置の見直し、月曜への予約分散、泌尿器科の新規レジメン増に対応する薬剤調製体制

中（年度内に検討すべき事項）

No.	論点	背景	検討すべき内容
8	査定率の目標達成	累計0.54%（目標0.40%）、査定額7,435万円	7-8月の高査定率（0.86%, 0.77%）の原因分析、診療科別フィードバック体制、再審査請求の回収率向上
9	病床稼働率の季節平準化	7-9月85-87%台の「谷」vs 2月94.0%の「山」	低稼働月の予定入院前倒し、看護師の有給取得平準化、手術室稼働の季節調整
10	外来ポートフォリオの再編	低単価患者21.6%（目標20.0%）、初診率7.4%（目標10.0%）	逆紹介推進の診療科別計画、低単価患者のかかりつけ医移行、新患獲得策

定点観測項目（毎月の会議で追跡）

項目	現状	目標/基準	次回確認ポイント
病床稼働率	88.9%（累計）	92.0%	3月実績（92%予想）が達成されたか
外来患者数	852.1人/日	910.0人/日	4月の新年度スタート時の患者動向
紹介件数	1,150件/月	1,300件/月	整形外科の紹介回復の兆候
手術件数	6,336件/年	—	来年度のペース（月530件水準を維持できるか）
ダヴィンチ	10.2件/月	16.7件/月（200件/年）	4月から新目標に向けた立ち上がり
査定率	0.54%	0.40%	改定後の新ルール対応状況
DPC係数	—	1.6055	4月の正式通知と算定への影響確認
マイナ保険証	65.3%	—	利用率の継続的な上昇傾向

IV. 添付資料一覧

資料番号	資料名
資料1	3病院収支比較表
資料1-1	医事統計（大橋病院診療実績）
資料1-2	診療科別前年（月平均）比較
資料1-3	土曜日実績（令和8年3月分）
資料2	外来化学療法加算算定状況
資料3	手術資料（2月・3月）
資料4	特定入院料算定状況
資料5	リハビリテーション算定状況

資料6	後発医薬品指数推移
資料7/7-1/7-2	紹介率・逆紹介率推移、病診連携室資料
資料8	退院支援関連項目算定状況
資料9	放射線治療算定状況
資料10	令和7年度3病院指摘検討事項

本議事録は会議での報告内容に、資料データに基づく示唆分析を付記したものです。
数値は原本資料を優先しています。会議中の口頭発言と資料に齟齬がある場合は資料データを採用しました。